3.2.5.2. 부록 1.

간호국 특수간호기술 매뉴얼 - 강박환자 간호

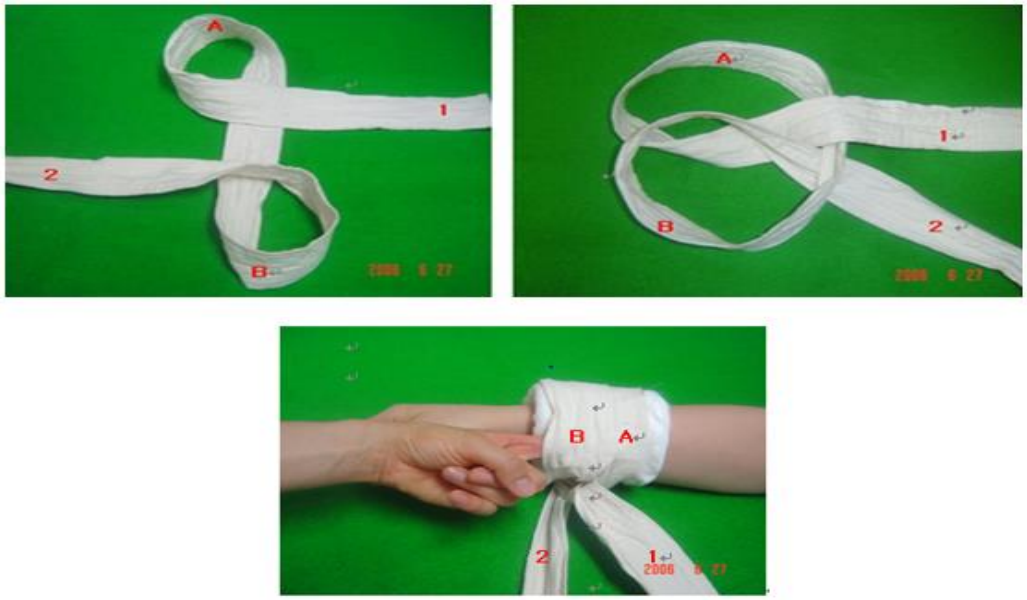
담당부서	간호국				
제정일	2012.02.	최종개정일	2025.03.	최종검토일	2025.03.

간호국 특수간호기술 매뉴얼-강박환자 간호

확인사항	내 용
1. 강박의 정의와 목적을 설명한다.	1) 목적 가) 환자의 권리와 권위를 최대한 존중하면서 환자를 안전하게 보호하기 위함이다. 나) 환자에게 적절한 절차에 의거하여 안전하고 효과적으로 사용하기 위함이다. 다) 강박이 부적절하게 사용되는 것을 막고, 일상적으로 꼭 필요하다고 판단되는 상황에서만 제한적으로 사용하기 위함이다. 2) 정의 환자의 신체활동을 제한하는 행위를 말하는데, 손목이나 발목을 신체보호대(끈 또는 가죽 등)로 고정시키거나, 벨트를 사용하거나, 보호복을 착용시키거나, 의자에 고정시키는 방법 등을 사용하는 것을 말한다.
2. 강박 환자 관리의 적응증을 설명한다.	1) 적응증 가) 자해 혹은 타해의 위험이 높은 환자 나) 정신적·신체적으로 환자 스스로의 건강을 심각하게 해할 우려가 높은 환자 다) 기물파손 등 병동 환경을 심각하게 훼손할 가능성이 높은 환자 라) 질병과 관련하여 지나친 자극을 줄여 자·타해 위험성을 감소시킬 필요가 높은 환자 마) 환자가 스스로 충동을 조절할 수 없다고 느껴 강박을 요구하는 환자 2) 준비물 : 신체보호대, 강박 부위만큼의 Cotton pad.
3. 강박 환자 관리지침을 설명한다.	1) 동의서 가) 의사가 환자 또는 보호자에게 직접 설명하고, '격리 또는 육체적 구속을 위한 안정관리동의서' 를 받는다. 나) 가능한 강박 시행 전에 의사가 그 이유를 환자 또는 보호자에게 설명하도록 하며, 불가피할 경우 강박 시행 후 설명할 수 있도록 한다. 다) 환자가 병식이 없는 경우를 제외하고는 환자의 동의 없이 강박을 시행할 수 없다. 라) 환자가 병식이 있는 경우에는 환자에게 반드시 강박 동의서를 받아야 하며, 병식이 없는 경우에 한해서 법적 동의자인 보호자에게 강박 동의서를 받는다. 마) 동의서는 입원기간 중 최초 시행 전 1회 받는다. 2) 강박 처방 가) 강박 시행 및 해지는 처방에 따라 시행한다 나) 매 강박 시 마다 의사가 처방한다. 3) 강박 시행 가) 강박은 격리를 시행한 이후 다음 단계로 시행한다. 강박 시행 장소는 타인에게 인격이 보호되는 장소로서 외부 창 또는 CCTV를 통해 관찰이 가능한 조용하고 안전한 환경에서 실시한다. 나) 안정실 내에는 자해의 위험이 있는 물건이나 소지품을 제거한다. 다) 환자 및 직원의 상해를 방지하기 위해 의료인(의사, 간호사) 포함 최소 2명 이상의 훈련된 직원들이 수행한다. 라) 강박을 실시하기로 결정이 되면, 환자가 스스로 협조할 수 있도록 시간을 준다. 마) 강박 시 환자의 증상, 행동조절 및 안정을 위하여 의사의 지시에 따라 약물을 투여한다. 바) 약물 투여과정은 '정신과적 응급상황에서 빠른 진정을 위한 정신과 약물 사용 지침', '소아청소년 환자의 빠른 진정에 관한 지침'을 따른다. 4) 강박 시행 후 환자 점검 사항 가) 최초 15분 이내에 환자의 정신상태와 행동 및 강박 부위의 사지감각, 피부색, 움직임, 피부온도 평가와 활력징후를 측정한다. 단, 진정약물을 투여했을 경우 최초

	5분 이내 활력징후를 평가한다. 나) 30분 마다 관찰 및 평가를 시행한다. 다) 1시간마다 다음을 수행한다. ① 환자의 정서적 안정상태 및 위험행동을 여부 등을 관찰한다. ② 피부색, 움직임, 피부온도, 활력징후를 평가, 기록한다. ③ 용변을 돕고 적절한 수분 및 영양을 공급한다. ④ 환자 상태에 이상이 있는 경우 즉시 담당의 또는 당직의에게 알린다. 라) 강박을 지속할 경우 2시간마다 강박을 풀고 사지운동을 시켜주고, 필요시 자세를 변경한다. 5) 강박 해제 기준 가) 환자상태가 안정되어 위험성이 없어졌다고 판단되면 즉시 담당의(또는 당직의)에게 알리고, 강박 해제 여부와 강박으로 인한 부작용 유무(피부손상, 근골격계 이상 등)를 확인한다. 나) 강박의 1회 처방 최대 허용시간은 19세이상 성인기준 4시간 이하이다. (19세미만 미성년자의 경우 2시간 이하) 강박은 전문의의 평가에 의해 연장할 수 있으나 1회 최대 허용시간의 2배수를 초과하지 않는다. 단, 위험성이 뚜렷하게 높아 연속 최대 허용 시간을 초과하여 강박이 필요한 경우 정신건강의학과 전문의의 대면평가를 거쳐 추가로 연장할 수 있다. 이 경우 4인 이상으로 구성된 다학제평가팀의 사후 회의를 통해 해당 강박 과정의 적합성을 검토하고 이를 별도의 회의록에 기록하여 보관한다.
4. 강박의 방법을 알고 수행한다.	1) 강박의 방법 ① 5Point 억제법 [그림 1] 5-point Restraint System ② 자석 억제대(사지, 가슴) [그림 2] 자석 억제대

2) 신체보호대 적용 방법



[그림 3] Clove Hitch 매듭의 신체보호대

3) 수행방법

가) 환자에게 목적과 방법을 설명한다. Clove Hitch 매듭의 신체보호대를 만든다.
나) 신체보호대를 적용할 부위의 피부상태를 확인하고 패드를 댄다.
다) 8자형으로 만든 신체보호대를 손목을 감싼 후 신체보호대와 피부 사이에 손가락 하나가 들어갈 수 있을 정도로 묶는다.

[그림4] 신체보호대의 매듭 방법

라) 침상 난간에 묶지 말고 침상 틀에 단단히 고정 시킨다.
마) 신체보호대를 침대에 묶을 때는 대상자의 체위가 바뀔 때를 대비하여 고정되어 있는 곳(침대의 머리부분)에 묶는다.
바) 환자가 안전한지 확인하고 침상 난간을 올려준다.
사) 강박한 부위의 혈액순환을 점검한다.
아) 15분 이내 vital sign을 체크하고 안정 시에는 1시간 마다 체크한다.
자) 2시간 마다 체위변경을 하고 피부상태를 확인한다.
차) 사지 강박을 해지 할 때에는 한곳씩 단계적으로 풀며, 마지막 두 곳은 동시에 푼다.

	 [그림5] 신체보호대의 해제
5. 간호기록을 정확하게 한다.	1) 강박 시작 시점부터 격리강박기록지 EMR 서식과 간호진단(상해의 위험 중에서 '신체보호대 사용' 간호 중재)를 이용하여 간호기록을 작성한다. 2) '신체보호대 사용' 간호 중재 중에서 실 시한 간호활동을 클릭하여 내용을 기록한다. 가) 신체보호대 사용에 대해 설명함 (교육내용, 사용과정, 사용목적, 제거 기준, 학습 장애요인, 교육매체, 교육방법, 교육자, 대상자, 교육 성취도) 나) 동의서를 받음 (대상: 환자/대리인 시행시기: 최초 시행 전 1회) 다) 신체보호대를 적용함(신체보호대 종류, 신체보호대 사용목적, 시행자) 라) 적용된 사지를 모니터함 (사지 부위, 사지 감각, 피부색, 움직임, 피부온도, capillary refill, 통증강도) 마) 요의를 사정함 바) 용변을 도와줌 (용변 보조 방법, 용변 보조 기구, 시행자) 사) 식사와 수분 필요량을 모니터 함 아) 약물을 투여함 자) 신체보호대 지속여부를 확인함(사용목적, 계속 또는 일부 유지 제거 등) 차) 신체보호대를 제거함(신체보호대 종류, 시행자) 3) 첫 15분 이내의 환자 관찰 내용을 기록하고, 이후 30분 마다 환자의 상태를 관찰, 기록한다. 1시간 마다 간호활동 내용을 기록한다. 4) 강박 해제 시 간호기록: 가) 상해의 위험 간호진단에서 간호중재로 신체보호대 사용을 선택하고 간호활동에 '신체보호대 종류'와 '신체보호대 제거함'을 기록한다. 나) 간호활동 중에서 '적용된 사지를 모니터함' 부분에서 사지감각과 피부손상 여부를 관찰하고 기록한다. 다) 신체보호대 해제 후 부작용 유무(피부손상, 근골격계 이상 등) 확인 후 기록한다.

▣ 참고문헌

임상간호 실무지침서(2017), 병원간호사회

Guidelines for psychiatric uses of seclusion and restraint, Task force of the American Psychiatric Association, 1984

Concise Guide to Psychiatry and Law for clinicians, 3rd Edition, American Psychiatric Publishing, 2001

Textbook of Clinical Psychiatry, 4th edition, Robert E. Hales, American Psychiatric Publishing, 2003

Synopsis of Psychiary, ninth edition, Benjamin James Sadock, Lippincott Williams & Wilkins, 2003

정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 <개정 2018.9>

2023년 정신건강 사업안내